

Nevus melanocítico

(Basado en Guías MINSAL Chile 2023, American Academy of Dermatology 2024, British Association of Dermatologists 2023, NCCN Guidelines 2024, Fitzpatrick's Dermatology 2023 y UpToDate 2025).

1. Introducción y relevancia clínica

Los **nevus melanocíticos**, también llamados **lunares**, son **proliferaciones benignas de melanocitos** que se originan en la epidermis, dermis o ambas.

Son extremadamente comunes en la población general, con un promedio de 20–40 lesiones por adulto.

Relevancia clínica

- Aunque benignos, algunos **pueden transformarse en melanoma maligno**, por lo que su evaluación es parte esencial del examen dermatológico.
 - La **detección precoz del melanoma** mediante la evaluación sistemática de nevus es un **objetivo prioritario de salud pública**, especialmente en países con alta exposición solar como Chile.
 - En el EUNACOM, el foco está en reconocer los **tipos de nevus**, aplicar la **regla del ABCDE** y conocer las **indicaciones de escisión y seguimiento**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Origen

Los **nevus melanocíticos** surgen por una **proliferación clonal de melanocitos** derivados de la cresta neural.

Pueden estar:

- En la **unión dermoepidérmica** (nevus juncional),
- En la **dermis** (nevus dérmico),
- O en ambas (nevus compuesto).

Estos melanocitos producen melanina y se agrupan formando **nidos o tecas** en las distintas capas de la piel.

2.2. Clasificación general

Tipo	Localización histológica	Edad de aparición	Aspecto clínico
Nevus juncional	Unión dermoepidérmica	Infancia-adolescencia	Mácula pigmentada plana
Nevus compuesto	Unión + dermis	Adolescencia-adultez	Pápula o nódulo pigmentado
Nevus dérmico	Dermis	Adultez	Pápula o nódulo del color de la piel o levemente pigmentado

2.3. Clasificación clínica según origen

1. **Nevus melanocítico congénito:** presente al nacer, derivado de alteraciones en la migración melanocitaria embrionaria.
 2. **Nevus melanocítico adquirido:** aparece durante la infancia y adolescencia por estímulos solares y hormonales.
 3. **Nevus atípico (displásico):** con alteraciones clínicas o histológicas, representa riesgo de transformación maligna.
-

2.4. Factores asociados

- **Genéticos:** mutaciones en BRAF, NRAS o GNAQ.
- **Exposición solar intermitente e intensa** (quemaduras solares en infancia).

- **Fototipo claro (I–II)** y piel con pecas.
 - **Historia familiar de melanoma o síndrome de nevus displásico.**
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Nevus melanocítico común (adquirido)

- Lesiones **simétricas, bien delimitadas**, redondeadas u ovaladas.
- Color uniforme: marrón claro, oscuro o negro.
- Diámetro <6 mm.
- Pueden ser planos (juncionales) o elevados (compuestos/dérmicos).
- Distribución más frecuente en tronco, cara y extremidades.

Evolución:

- Aparecen en la infancia, aumentan durante la pubertad y pueden involucionar con la edad.
 - No producen síntomas (sin prurito, sangrado ni dolor).
-

3.2. Nevus melanocítico congénito

- Presente al nacimiento o en los primeros meses.
 - Puede ser pequeño (<1,5 cm), mediano (1,5–20 cm) o gigante (>20 cm).
 - Superficie rugosa o con pelo terminal (“nevus piloso”).
 - Riesgo de melanoma:
 - Bajo en pequeños (<1%).
 - **Alto en gigantes (5–10%)**, especialmente en la infancia.
-

3.3. Nevus displásico (atípico)

- Lesiones con **asimetría, bordes irregulares y coloración heterogénea**.
 - Tamaño >6 mm, con halo eritematoso o aspecto de “huevo frito”.
 - Su presencia indica **mayor riesgo de melanoma**, especialmente si existen múltiples (>5) o antecedentes familiares.
 - Parte del **síndrome del nevus displásico (síndrome de melanoma familiar)**.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Lesión	Características distintivas
Melanoma	Asimetría, bordes irregulares, varios colores, >6 mm, evolución rápida
Lentigo solar	Mácula marrón en zonas fotoexpuestas, en adultos mayores
Queratosis seborreica	Lesión verrucosa, aspecto “pegado”
Dermatofibroma	Nódulo firme, signo del hoyuelo positivo
Angioma	Color rojo brillante, no pigmentado

3.5. Regla del ABCDE para sospecha de melanoma

Letra	Significado	Hallazgo sospechoso
	o	

A	Asimetría	Mitades no iguales
B	Bordes	Irregulares, mal definidos
C	Color	Varias tonalidades
D	Diámetro	>6 mm
E	Evolución	Cambio en tamaño, forma, color, sangrado o prurito

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico de nevus melanocítico es **clínico y dermatoscópico**.

La **dermatoscopia** permite evaluar patrones benignos o sospechosos de malignidad.

4.2. Dermatoscopía

- **Patrones benignos:** red pigmentaria regular, simétrica, homogénea.
 - **Patrones atípicos o malignos:** red irregular, velos azules-blancos, puntos y glóbulos irregulares.
-

4.3. Biopsia

Indicada cuando:

- Lesión **atípica o cambiante (ABCDE positivo)**.

- **Nevus congénito gigante.**
- Diagnóstico clínico incierto.
- **Historia de melanoma familiar.**

Tipo: **escisional con márgenes estrechos (2 mm)**, incluyendo toda la lesión.

4.4. Criterios diagnósticos

- **Nevus común:** lesión simétrica, uniforme, <6 mm, color homogéneo, estable.
 - **Nevus displásico:** asimétrico, bordes irregulares, varios colores, >6 mm.
 - **Nevus congénito:** presente al nacer, superficie rugosa o pilosa.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile, 2023)

5.1. Conducta general

- **Nevus común y estable:** observación clínica anual.
 - **Nevus sospechoso (ABCDE):** escisión completa con estudio histopatológico.
 - **Nevus congénito gigante:** evaluación quirúrgica temprana por riesgo de melanoma.
 - **Nevus displásico:** extirpación si hay cambios clínicos o antecedentes familiares de melanoma.
-

5.2. Tratamiento quirúrgico

Tipo de lesión	Conducta recomendada
Nevus benigno común	No requiere extirpación si estable

Nevus sospechoso / displásico	Escisión completa con 2 mm de margen clínico
Nevus congénito gigante	Resección seriada o injertos según tamaño
Nevus irritado o traumático	Extirpación por precaución

Nunca se debe realizar destrucción con láser o crioterapia sin histología previa en lesiones pigmentadas sospechosas.

5.3. Seguimiento

- **Autoexamen mensual:** frente a espejo, incluyendo cuero cabelludo, uñas y plantas.
- **Examen dermatológico anual** en población general.
- Cada **6 meses** en pacientes con múltiples nevus o antecedentes familiares de melanoma.
- Fotografía corporal total para seguimiento digital.

5.4. Educación y prevención

- Evitar exposición solar intensa, especialmente en infancia.
- Uso diario de protector solar FPS ≥ 50 .
- No manipular ni rascar nevus.
- Educar sobre la regla **ABCDE** y signos de alarma.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
--------------	-------------

Transformación maligna Especialmente en nevus congénito gigante o displásico

Cicatriz postquirúrgica Tras resección de nevus grandes

Infección o sangrado Postoperatorio poco frecuente

Alteración estética En nevus visibles o múltiples

Pronóstico:

- Excelente para nevus benignos.
- Riesgo vital si degeneran a melanoma, pero detectado precozmente el pronóstico es curable (>95% supervivencia a 5 años).
- El seguimiento sistemático permite diagnóstico precoz y reducción de mortalidad por melanoma.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Nevus común:** simétrico, homogéneo, <6 mm, sin evolución.
2. **Nevus displásico:** asimétrico, irregular, heterogéneo, >6 mm.
3. **Nevus congénito gigante:** riesgo de melanoma → seguimiento o escisión temprana.
4. **Regla ABCDE** es clave en el examen clínico de toda lesión pigmentada.
5. **Toda lesión pigmentada que cambia debe extirparse completamente con biopsia.**

6. **Nunca destruir sin histología previa.**
 7. En **EUNACOM**, las preguntas frecuentes evalúan **diferencia entre nevus benigno y melanoma** y la **conducta ante lesión sospechosa**.
-



Errores comunes

- Observar un **nevus cambiante** sin realizar biopsia.
 - **Destruir con crioterapia o láser** sin estudio histológico.
 - No enseñar **autoevaluación y fotoprotección**.
 - Confundir **nevus displásico** con melanoma incipiente.
 - Ignorar antecedentes familiares de melanoma en la conducta terapéutica.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **nevus melanocíticos** son proliferaciones benignas de melanocitos, que pueden ser congénitos o adquiridos.
2. La **regla ABCDE** es fundamental para detectar signos de transformación maligna.
3. El **diagnóstico es clínico y dermatoscópico**, confirmable con biopsia si hay sospecha.
4. La **escisión completa con márgenes estrechos** es el manejo de elección en lesiones atípicas.
5. El **nevus congénito gigante** conlleva mayor riesgo de melanoma.
6. La **educación y fotoprotección** son pilares preventivos.
7. En EUNACOM, la clave está en **reconocer el patrón benigno vs sospechoso**, y **actuar ante cambios evolutivos**.